

NOTULEN

HARI / TANGGAL : RABU / 11 MARET 2026
PUKUL : 15.00 – SELESAI
JENIS MEETING : RAPAT KOORDINASI TEMUAN AUDIT TKMKB BPJS
TEMPAT : RUANG MEETING KANTOR PT DPM

NO	POKOK BAHASAN	TEMUAN KASUS	TINDAK LANJUT	PIC
1	Audit tindakan sectio caesaria	SC dilakukan tanpa indikasi yang tepat	Apakah RS sudah punya SOP untuk alur pasien SC elektif? Kasus apa saja yang bisa SC elektif? Bila ada rencana SC elektif, siapa yang berhak ACC?	Manajerial RS
		Kasus KPD tanpa ada upaya persalinan pervaginam	Lembar observasi PONEK (mulai vital sign sampai VT) untuk membuktikan adanya upaya persalinan pervaginam dulu	Manajerial RS
		Lilitan tali pusat tanpa upaya partus percobaan	Lembar observasi PONEK pakai yang terbaru by pak puguh (ada di mbak Kiki) Di E-RM kan	
		CPD tanpa ada keterangan ukuran panggul	Lembar observasi diisi sejak pasien masuk PONEK dan dibawa sampai pasien ke Mater Di ponek harus ada alat ukur panggul, tinggi badan, berat badan	Manajerial RS
		SC dengan indikasi oligohydramnion	Pastikan ada hasil foto USG yang menunjukkan AFI <4	
			RS harus punya kebijakan bila ada pembukaan <3 cm maka masuk tidak gawat dan diskema rawat jalan (pembayaran umum) KIE yang baik	Manajerial RS
		Myopia spheris -7 tidak ada hasil pemeriksaan spesialis mata	Bila saat kontrol ANC ditemukan kelainan mata (myopia) maka SpOG wajib konsul ke SpM	Manajerial RS

			Kalau FKTP rujuk pasien hamil dengan myopia, rujuknya ke obgyn dulu, nanti obgyn baru konsul ke mata	
		Terminasi kehamilan karena PEB tanpa ada upaya induksi	Pastikan diagnosis PEB sudah tegak dengan adanya proteinuria dan tensi tinggi	Manajerial RS
		Primi tua bukan indikasi absolut SC	Bila pasien primi tua, cari diagnosis lain yang mendukung indikasi SC	Manajerial RS
		Fetal distress + NST normal	Harus ada di planning / terapi : dilakukan miring kiri, rehidrasi, dan oksigenasi	Manajerial RS
		Tidak sinkron data di CPPT dan resume medis	Triage, lembar observasi ponek, asesmen awal medis, CPPT, resume menjadi 1 kesatuan dokumen klaim	Manajerial RS
		Coding ICD 10	Diagnosis penyulit + SC elektif / emergency Harus bisa membedakan diagnosis penyulit nya adalah indikasi untuk SC elektif atau SC untuk emergency	Manajerial RS
		Temuan administratif	• Segera buat rapat koordinasi dengan PONEK, MATER • Rapat dengan DPJP terkait indikasi medis SC • Sosialisasi lembar observasi PONEK terbaru • Sosialisasi hasil audit SC dari BPJS • Sosialisasi ke verifikator untuk coding SC tidak boleh unspecified • TL lain sesuai hasil rekomendasi TKMKB BPJS terkait audit medis SC	Manajerial RS
2	Kendali biaya	Pahami SHP (strategic health purchasing)	• Lihat Perpres untuk cek apakah pemeriksaan ditanggung atau tidak • Penilaian teknologi kesehatan / HTA (kapan suatu diagnosis membutuhkan suatu pemeriksaan penunjang)	Manajerial RS
3	Sistem rujukan	Rujuk eksternal Pasien dirujuk karena RS tidak memiliki sumber daya	• Buat alur ACC penerimaan rencana rujukan dari RS lain • Harus ditanyakan kepada RS perujuk : diagnosis, indikasi rujukan, mau ke DPJP siapa, butuh sarana prasarana apa	Manajerial RS

		Inventaris sumber daya baik alkes maupun SDM (spesialis/subspesialis) Indikasi rujukan harus jelas	- Bila mau merujuk : pastikan memang di RS tidak ada sumber daya tersebut Contoh CVA perdarahan : sepakati dengan DPJP SpBS kasus apa saja yang perlu dirujuk (LOS panjang tidak bisa dijadikan indikasi rujuk)	
		Rujuk parsial	Rujukan karena kebutuhan penegakan diagnosis	Manajerial RS
4	Kasus non spesialistik	Kasus non spesialistik saat rujukan pertama masih bisa diterima Yang tidak boleh ketika kasus non spesialistik minta dikontrolkan	Sosialisasi ulang	Manajerial RS
5	Kegawatan	Kriteria hijau	Tidak apa-apa dipulangkan dengan skema pembayaran umum Tidak usah dipaksakan menggunakan BPJS	Manajerial RS
		Kasus pasien rujuk eksternal menunggu lama	- Bisa dibuatkan ruang transit sambil menunggu ACC rujukan - Tidak apa apa tetap diberi makan - Lembar observasi tetap berjalan dan masih tanggung jawab dr IGD - Prinsip : masih pasien IGD tapi hanya beda ruangan saja agar pasien nyaman	Manajerial RS

Pemimpin Rapat



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE



Nomor : 8002/VII-05/0925

Malang, 23 September 2025

Hal : Tindak Lanjut Hasil Audit Medis Sectio Caesaria

Yth. Direktur/Kepala FKRTL Mitra BPJS Kesehatan Cabang Malang
di
Malang Raya

Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan audit medis Sectio Caesaria yang telah dilaksanakan oleh TKMKB Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Agustus 2025, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil Audit Medis Sectio Caesaria:

a. Temuan medis

1) Prosedur SC dilakukan tanpa indikasi medis yang jelas, seperti:

- Kasus KPD tanpa ada upaya persalinan pervaginam /induksi.
- Belum memenuhi kriteria induksi gagal, seperti: tidak mencantumkan indikasi gagal maternal maupun fetal, belum mencapai 2 kolf sudah dikatakan gagal. BSC 1x tanpa ada indikasi lainnya
- Oligohydramnion tidak ada keterangan AFI pada hasil foto USG (AFI <4 absolut SC, jika AFI <8 harus ada penyebab lain yang mendukung)
- Lilitan tali pusat tanpa upaya partus percobaan
- Prolonged kala 1 fase laten (pembukaan <3) seharusnya ditunggu/ dipulangkan dulu
- Prolonged kala 1 fase aktif tanpa upaya induksi akselerasi dan tidak didapatkan keterangan kelainan presentasi (letak puncak).
- CPD(disproporsi) tanpa ada keterangan ukuran panggul dalam (baik saat ANC/MRS)
- Myopia dengan spheris -7 tidak ada hasil pemeriksaan spesialis mata dengan keterangan kelainan/degenerasi retina
- Terminasi kehamilan karena PEB (tidak ada kontraindikasi persalinan pervaginam) tanpa ada upaya induksi

Kantor Cabang Utama Malang

Jl. R. Tumenggung Suryo 44 Malang

Telp. +62 341 493026

Fax. +62 341 493802

www.bpjs-kesehatan.go.id

- Primi tua/ HSVB bukan merupakan indikasi absolut SC
 - Bayi besar namun tidak ada data yang mendukung (TFU >40 cm, BB bayi saat lahir >3800gr, TBJ dari USG)
 - Fetal distress dengan hasil NST normal dan tidak ada tatalaksana rehidrasi O² miring kiri.
- 2) Pemberian induksi pada pasien dengan kontraindikasi (dilakukan induksi pada pasien BSC, CPD).
 - 3) Ditemukan adanya kesalahan dalam interpretasi hasil NST.
 - 4) Ditemukan diagnosis PEB yang tidak memenuhi kriteria diagnosis PEB.
- b. Temuan administratif
- 1) Ditemukan inkonsistensi penulisan rekam medis
 - Terdapat penambahan diagnosis dengan bentuk tulisan yang berbeda
 - Variasi bentuk tanda tangan DPJP
 - Data di resume medis tidak tertulis dengan lengkap (sesuai dengan rekam medis) untuk menunjang diagnosis akhir pasien, baik pada anamnesis, pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang
 - Data penunjang suatu diagnosis tidak lengkap (bayi besar, tidak ada informasi di rekam medis untuk menunjang diagnosis bayi besar)
 - Terdapat inkonsistensi pencatatan pada lembar triase, lembar CPPT dan lembar assesmen rawat inap DPJP
 - Terdapat coretan penulisan tekanan darah pada lembar assesment rawat inap DPJP dan CPPT
 - Terdapat kasus pada lembar CPPT tercatat VT pembukaan 1, sedangkan pada resume tercatat tidak ada pembukaan.
 - 2) Ditemukan lembar partograf yang tidak diisi.
 - 3) Tidak dituliskan hasil bacaan USG.
 - 4) Tidak dituliskan kondisi bayi baru lahir di laporan operasi (berat bayi, jenis kelamin dll).
 - 5) Terdapat potensi rujukan berasal dari bidan praktek tertentu, tanpa indikasi medis yang jelas.
 - 6) Ditemukan asal masuk pasien tidak jelas (bukan poli/ UGD) melainkan "Pasien Datang Sendiri" dengan indikasi SC tidak jelas.
 - 7) Beberapa Protap terkait tindakan obstetri misalnya Protap induksi kehamilan belum ada

2. Rekomendasi TKMKB terkait Audit Medis Sectio Caesaria:

a. Untuk Manajemen RS:

- 1) Revisi PPK kasus sectio caesaria untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan pedoman/guideline agar disusun kembali sesuai acuan terbaik, dan dikomunikasikan dengan Perhimpunan Profesi terkait.
- 2) Melakukan perbaikan dan pembinaan terhadap seluruh jajaran tenaga medis maupun paramedis dalam hal ketertiban dalam penulisan rekam medis pasien.
- 3) Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan RS yang dapat berperan secara maksimal dan berintegritas dalam mencegah terjadinya potensi ketidaksesuaian.

b. Untuk DPJP:

- 1) Melakukan prosedur SC sesuai indikasi yang benar berdasarkan pedoman klinis yang berlaku dan acuan terkini yang direkomendasikan.
- 2) Menuliskan rekam medis maupun resume medis secara lengkap dan baik.

c. Untuk Dokter Umum dan Bidan:

- 1) Di IGD, dokter umum dan bidan harus memahami kriteria gawat darurat kebidanan.
- 2) Di ruangan, bidan harus memahami kriteria gawat darurat maternal dan gawat darurat janin dan memahami proses persalinan sesuai dengan APN (asuhan persalinan normal).
- 3) Bidan wajib tertib dalam menuliskan pemantauan partograf

Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi panduan dalam kendali mutu pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pps Kepala

Ariyanti

Tembusan: Ketua TKMKB Cabang Malang.

AN/de/pk00